

FRACTURAS DE LA ÓRBITA

Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno, Raúl Antúnez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso

INTRODUCCIÓN

El tratamiento de las lesiones orbitarias es uno de los campos de mayor interés y dificultad de la traumatología facial.

Recuerdo anatomía orbitaria

El esqueleto orbitario está formado por siete huesos (huesos frontal, esfenoides, cigomático, maxilar, etmoides, lacrimal y palatino), que forman parte del esqueleto cráneo-facial. Al reunirse se disponen como una pirámide de 4 lados, formando las paredes de la órbita y sirviendo de recipiente para los globos oculares.

El nervio infraorbitario (V2 del nervio trigémino) discurre por el suelo de la órbita y da sensibilidad a la mejilla, ala nasal, labio superior, encía y en algunas ocasiones a la conjuntiva ocular.

Epidemiología

En el esqueleto facial, las fracturas de órbita son las segundas en frecuencia tras las fracturas nasales. Las principales causas son los accidentes de tráfico, las caídas y las agresiones.

Clasificación de las fracturas orbitarias

Fracturas Blow-Out

Las fracturas puras del suelo de la órbita o tipo Blow-out son fracturas que se producen tras un traumatismo directo con objetos no penetrantes, como una pelota o tras un puñetazo. El aumento brusco de la presión intra-orbitaria busca una descompresión por una de sus paredes más débiles, que son el suelo y la pared medial de la órbita, produciéndose una herniación de contenido orbitario en los senos paranasales.

El paciente asociará con mucha frecuencia una inflamación periorbitaria, enfisema tras una maniobra de valsalva y/o limitación de los movimientos oculares con visión doble a la supra y/o infraversión.

Fracturas Tipo Trap-Door

Se trata de una variante poco frecuente. Paciente pediátricos y jóvenes. Se trata de un mecanismo de fractura similar al Blow-out, pero en la que la porción de hueso fracturado vuelve a su posición inicial, capturando así el músculo recto inferior. El paciente presentará en la exploración física una limitación en la movilidad ocular. No se aprecia fractura en las pruebas de imagen.

DIAGNÓSTICO

Es eminente clínico y se confirma con pruebas de imagen, de elección TAC Craneo-facial.

Diagnóstico Clínico

Los signos clínicos que encontramos en las fracturas de órbita son:

- Inflamación periorbitaria
- Limitación movimientos oculares
- Visión doble

- Escalón óseo en reborde infraorbitario
- Hemorragia subconjuntival
- Distopía ocular

Diagnóstico radiológico

Cuando los signos de alarma estén presentes habrá que solicitar una tomografía computarizada asociando cortes axiales, sagitales y coronales.

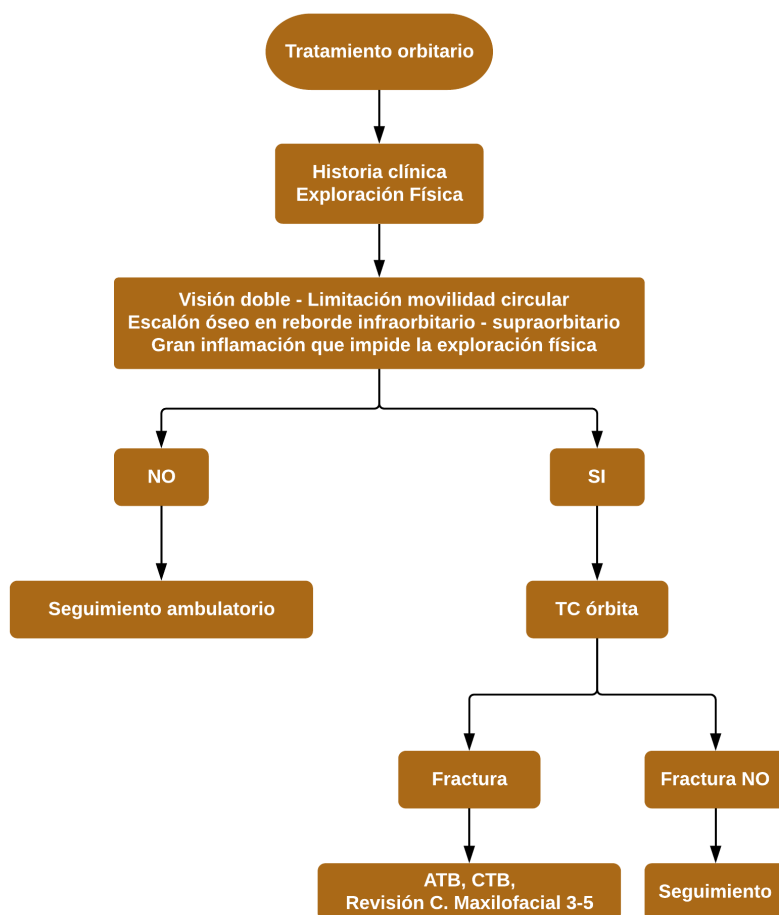
Para tomar una determinación quirúrgica ante una fractura de suelo de órbita cobra más importancia la exploración física. Es importante tener en cuenta que un alto porcentaje de fracturas de suelo de órbita no tienen repercusión clínica en el paciente y por ello el manejo es conservador.

TRATAMIENTO

Una vez diagnosticada la fractura orbitaria, presente el paciente clínica asociada o no (visión doble o alteraciones estéticas), se remitirá de manera preferente/urgente para valoración por el Cirujano Maxilofacial en el plazo de 3-5 días y así determinar si la fractura requiere de tratamiento quirúrgico.

Recomendamos como tratamiento de cara al alta:

- Cobertura antibiótica de amplio espectro
 - Amoxicilina-clavulánico 500/125mg-875/125mg, 1 cada 8 horas durante 7-10 días
 - Clindamicina 600mg cada 8 horas durante 7-10 días en alérgicos a la penicilina.
- Analgésicos/Antiinflamatorios
 - Paracetamol, Metamizol, Dexketoprofeno según escala del dolor.
- Corticoides en pauta descendente.
 - Deflazacort 30mg:
 - 1 comprimido cada 12 horas durante 2 días.
 - 1 comprimido cada 24 horas durante 2 días.
 - Medio comprimido cada 24 horas durante 2 días y luego suspender.
- Evitar maniobras de Valsalva (Estornudar con la boca abierta, evitar esfuerzos y ejercicio físico, no sonarse los mocos, etc.)



BIBLIOGRAFÍA.

- García Marín F, Ochandiano Caicoya S. Cirugía oral. Carlos Navarro Vila. 2ª ed. Madrid: Aran; 2009.
- Norton NS. Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos. 3ª ed. Barcelona:Elsevier; 2018.
- Andersson L, Kahnberg K-E, Pogrel MA. Oral and Maxillofacial Surgery. United Kingdom: Wiley-Blackwell; 2010.